



חוברת עזרה ראשונה

053-9111-505

יצחק

תוכן עניינים

מצבי חירום רפואיים

- עילפון - עמוד 26
- אלרגיה ושוק אנפילקטי - עמוד 27
- הרעלות - עמוד 29
- אוטם בשריר הלב - עמוד 30
- סוכרת והיפוגליקמיה - עמוד 31
- שבץ מוחי - עמוד 34
- פרכוסים - עמוד 36

מצבי סביבה

- התייבשות - עמוד 38
- היפותרמיה - עמוד 41
- הכשת נחש - עמוד 43

טראומה

- מבוא לטראומה - עמוד 40
- פגיעות ראש - עמוד 45
- חבלה בעמוד שדרה - עמוד 46
- פגיעות חזה - עמוד 47
- שברים בגפיים - עמוד 48

מבחן לדוגמא

- מבחן לדוגמא - בחן את עצמך - עמוד 58
- תשובות למבחן - עמוד 63

יסודות עזרה ראשונה

- מהי עזרה ראשונה - עמוד 3
- משולש החיים - עמוד 4
- המוח ואספקת חמצן - עמוד 5
- תפקיד הלב - עמוד 7
- מערכת הנשימה - עמוד 8

הערכת מצב

- סיווג רמות הכרה - עמוד 9
- מדדים חיוניים - עמוד 23
- דופק ולחץ דם - עמוד 24

החייאה

- סכמת החייאה למבוגר - עמוד 10
- החייאת ילד - עמוד 13
- דפיברילטור - עמוד 14
- החייאת תינוקות - עמוד 15

מצבי חירום נשימתיים

- חנק מגוף זר - עמוד 18
- אסתמה - עמוד 32

מהי עזרה ראשונה?

עזרה ראשונה היא מתן סיוע מיידי לאדם שנפגע או חלה בפתאומיות, עד להגעת צוות רפואי מקצועי.

תמיכה ראשונית

סיוע עד קבלת טיפול רפואי מתקדם

מניעת החמרה

עצירת התדרדרות המצב והגנה על הנפגע

הצלת חיים

מתן טיפול מיידי שיכול להציל את חיי הנפגע

חשוב לזכור

עזרה ראשונה יכולה לעשות את ההבדל בין חיים ומוות ולמנוע נזקים בלתי הפיכים. כל שנייה קריטית במצבי חירום.

משולש החיים

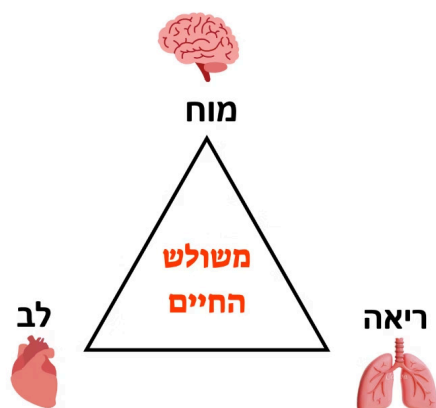
משולש החיים מייצג את שלושת האיברים החיוניים ביותר לקיום החיים: **המוח, הלב והריאות**. פגיעה באחד מהם מהווה סכנת חיים מיידית.



עיקרון קריטי

פגיעה באחד משלושת האיברים החיוניים – מוח, לב או ריאות – מהווה סכנת חיים מיידית ודורשת התערבות מיידית. כל אחד מהאיברים הללו אחראי לתפקוד חיוני שמבטיח את המשך חיי הגוף.

המוח – מרכז השליטה של הגוף



המוח הוא האיבר המרכזי של מערכת העצבים, אשר אחראי על ניהול ותיאום כל תפקודי הגוף, פיזיים וקוגניטיביים כאחד.

תפקודים עיקריים

- שליטה על תפקודים חיוניים אוטומטיים: נשימה, קצב הלב, ויסות חום הגוף ולחץ הדם
- תפקודים קוגניטיביים: חשיבה, למידה, זיכרון, קבלת החלטות ותחושת רגשות
- מערכת מוטורית: שליטה על תנועות רצוניות ובלתי רצוניות

חשיבות אספקת החמצן למוח

דקות קריטיות

תוך 4-6 דקות ללא חמצן, המוח מתחיל לסבול מנזק תאי בלתי הפיך

צריכת חמצן

המוח צורך 20% מכלל החמצן בגוף, למרות שמהווה רק 2% ממשקלו

נזק מוחי מחוסר חמצן

הפסקת אספקת החמצן למוח היא מצב מסכן חיים שדורש התערבות מידית.



השפעות נוספות של נזק מוחי

- פגיעה בתפקודים קוגניטיביים (חשיבה, זיכרון, למידה)
- פגיעה בתנועות מוטוריות
- אובדן הכרה ממושך (תרדמת)
- מוות מוחלט

תפקיד הלב במערכת הגוף

הלב הוא האיבר המרכזי במערכת הדם, ותפקידו לשאוב דם ולהזרים אותו דרך כלי הדם לכל חלקי הגוף.

פעולה מתמשכת

פועל בצורה מתמשכת באמצעות התכווצויות סדירות

סילוק פסולת

מסייע בסילוק פסולת מטבולית ופחמן דו-חמצני מהרקמות

אספקת חמצן

הלב מספק חמצן וחומרים מזינים לכל התאים בגוף

קצב הלב התקין

תינוקות וילדים

100-160 פעימות לדקה

קצב גבוה יותר לתמיכה בתהליכי גדילה

מבוגרים

60-100 פעימות לדקה במנוחה

יכול לעלות בזמן פעילות גופנית או במצבי לחץ

דום לב והשלכותיו

דום לב מתרחש באופן פתאומי או כתוצאה מפגיעה באחת או יותר ממערכות הגוף. במצב של דום לב, החמצן לא מגיע למוח ולאיברים חיוניים, מה שגורם לאובדן הכרה ולנזק בלתי הפיך תוך דקות ספורות. החייאה מהירה (CPR) יכולה לשמור על זרימת דם בסיסית עד להגעת צוות רפואי.

מערכת הנשימה

תפקידי מערכת הנשימה

- אחראית להכניס חמצן לגוף ולהוציא ממנו פחמן דו-חמצני
- מורכבת מדרכי הנשימה העליונות והתחתונות
- מאפשרת חילוף גזים בין האוויר החיצוני לדם
- התהליך מתחיל בהכנסת האוויר דרך האף או הפה, ממשיך דרך קנה הנשימה, הברונכים, ומגיע לריאות

הריאות – איבר מרכזי במערכת הנשימה

קצב נשימה תקין

מבוגרים: 12-20 נשימות בדקה

תינוקות: 30-60 נשימות בדקה

הריאות מכניסות חמצן לדם ומסלקות פחמן דו-חמצני. תהליך זה מתרחש בנאדיות הריאה.

חוסר תפקוד של הריאות עלול לגרום לחנק ולנזק מוחי, בשל מחסור בחמצן.

משמעות מצוקה נשימתית

חריגה מקצב נשימה תקין יכולה להצביע על מצוקה נשימתית, מצב מסוכן שדורש טיפול מיידי. חשוב לוודא תפקוד תקין של הריאות והדרכים הנשימתיות כדי למנוע נזק בלתי הפיך לגוף ולמוח.

סיווג רמות הכרה במטופל

הערכת רמת ההכרה היא שלב קריטי בבדיקת מצב הנפגע. השתמש בשיטת **AVPU** לסיווג מהיר.

1

A - Alert (הכרה מלאה)

המטופל ערני ומגיב לכל גירוי בסביבה. הוא יכול לדבר ולהגיב לפקודות ולשאלות.

2

V - Verbal (מגיב לקול)

המטופל מגיב לצלילים או קול, אך ייתכן שהתגובה לא תהיה תמיד ברורה. למשל, הוא עשוי לפתוח עיניים או להזיז יד, אך לא בהכרח להבין את השאלה או את הפקודה שניתנה.

3

P - Pain (מגיב לכאב)

המטופל לא מגיב לצלילים או לקולות, אך הוא מגיב לכאב. כלומר, כשהוא מקבל גירוי כואב (כמו לחיצה על הטרפזים), הוא יראה סימני תגובה כמו תנועה או שינוי במצב הגוף.

4

U - Unconscious (חוסר הכרה)

המטופל לא מגיב כלל לכל גירוי, לא קול ולא כאב. הוא נמצא במצב של חוסר הכרה מוחלט, ויש צורך לפעול במהירות ולספק טיפול חירום.

חשוב לזכור

סיווג זה יעזור לך להעריך את חומרת המצב ולקבוע את סדר העדיפויות בטיפול. במצב של חוסר הכרה מוחלט, יש לבדוק נשימה מיידיית ולהתחיל בהחייאה במידת הצורך.

סכמת החייאה למבוגר (CPR)

החייאה היא פעולה מצילת חיים שמטרתה לשמור על זרימת דם למוח עד להגעת עזרה רפואית. כל דקה קריטית!

בדיקת הכרה

קרא לנפגע בקול רם ונסה לעורר אותו על ידי טלטול עדין של הכתפיים או צביטה. לבדיקת רמות הכרה עיין בעמוד 9

בדיקת נשימה

בדוק אם הנפגע נושם על ידי התבוננות בתנועות החזה והרגשת נשיפה. אם הנפגע לא נושם - התחל בהחייאה מיידי.

בדיקת בטיחות

וודא שהסביבה בטוחה לפעולה - אין סכנה של חשמל, אש או כלי רכב. הגן על עצמך תחילה.

עיסויי חזה

הנח את כפות הידיים במרכז החזה ולחץ בעומק של 5-6 ס"מ בקצב של 100-120 לחיצות לדקה. המשיך עד הגעת מד"א או עד השימוש בדפיברילטור.

צלצול למד"א והבאת דפיברילטור

התקשר מיד למד"א (101) או בקש ממשהו אחר לבצע את השיחה. במקביל, בקש להביא דפיברילטור קרוב במידת האפשר.

טכניקת עיסויי חזה נכונה

מיקום הידיים

- הנח את כף יד אחת במרכז החזה, בין הפטמות
- הנח את כף היד השנייה מעל הראשונה
- שלב את האצבעות והרם אותן מהחזה
- שמור על זרועות ישרות ומרפקים נעולים

ביצוע הלחיצות

- עומק: 5-6 ס"מ
- קצב: 100-120 לחיצות לדקה
- אפשר לחזה לחזור למצבו המלא בין לחיצות
- מזער הפסקות בעיסויים

טיפ חשוב

כדי לשמור על קצב נכון של 100-120 לחיצות לדקה, אפשר לחשוב על השיר "Stayin' Alive" או לספור בקצב מהיר. **עיסויים איכותיים הם המפתח להצלחת ההחייאה!**

סימנים לעיסויים יעילים

- החזה יורד בעומק מספיק (5-6 ס"מ)
- הקצב נשמר קבוע
- המטפל לא עייף מדי (החלף מטפלים כל 2 דקות במידת האפשר)

מתי להפסיק החייאה?

המשך בעיסויי חזה עד שאחד מהמצבים הבאים מתרחש:

הנפגע מראה סימני חיים

הנפגע מתחיל לנשום באופן תקין, זז או מראה סימני הכרה

הגעת צוות רפואי

צוות מד"א או רופא הגיעו למקום ולקחו על עצמם את הטיפול

אתה במצב של סכנה

הסביבה הפכה למסוכנת או שאתה במצב של תשישות קיצונית

דפיברילטור מחובר

דפיברילטור הגיע והוחבר לנפגע - עקוב אחר הנחיות המכשיר

חשוב לזכור

אל תוותר! גם אם נראה שההחייאה לא עובדת, המשך בעיסויים. אתה שומר על זרימת דם מינימלית למוח, מה שיכול להציל חיים. סטטיסטיקות מראות שהחייאה מיידית מכפילה ואף משלשת את סיכויי ההישרדות.

החייאת ילד (מגיל 1 עד גיל 8)

עקרונות כלליים

הגדרת גיל: ילד מוגדר מגיל שנה ועד גיל 8 שנים. מבחינת הסכימה אין שוני מהותי בין החייאת מבוגר להחייאת ילד.

התייחסות לאנטומיה

חשוב להתייחס להבדלים האנטומיים הקיימים בין ילדים למבוגרים:

- גודל הגוף הקטן יותר
- מבנה בית החזה העדין יותר
- גמישות רבה יותר של כלוב הצלעות

דגשים מיוחדים

- **שימוש ביד אחת:** בהחייאת ילד יש להשתמש ביד אחת כדי לבצע עיסוי לבבי
- **עומק עיסוי הלב:** יש ללחוץ בעומק של 3-4 ס"מ (לא 5-6 ס"מ כמו במבוגר)
- **קצב:** 100-120 לחיצות לדקה (זהה למבוגר)

זכור

הסכימה זהה למבוגר: בדיקת בטיחות → בדיקת הכרה → בדיקת נשימה → צלצול למד"א → עיסויים. לסכימה המלאה עיין בעמוד 10



דפיברילטור (AED)

דפיברילטור הוא מכשיר רפואי חיוני במצבי חירום, שמטרתו העיקרית היא לספק שוק חשמלי כחלק מתהליך ההחייאה.

שיפור סיכויי הישרדות



באמצעות השוק, הדפיברילטור מאפשר למטפלים לבצע עיסויים בצורה הרבה יותר יעילה, ובכך להגדיל את הסיכוי להחזרת זרימת הדם התקינה

הנחיות קוליות



המכשיר מלווה את המטפל שלב אחר שלב במהלך ההחייאה, ומעניק הנחיות קוליות ברורות כדי להנחות את הפעולה הנדרשת

שוק חשמלי



תפקיד השוק החשמלי הוא לאפס את הלב במצב של פרפור חדרים, שבו הלב לא מצליח לפעול בצורה תקינה

קריטי לדעת



השימוש המיידی בדפיברילטור הוא קריטי - כל דקה חשובה בשיפור סיכויי ההישרדות של הנפגע. דפיברילטורים אוטומטיים (AED) קלים לשימוש ומתאימים גם למי שאין לו הכשרה רפואית.

החייאת תינוקות (עד גיל שנה)

סדר פעולות החייאה בתינוקות

2

בדיקת הכרה

קרא לתינוק בשמו, טפח עדין על גבו או דגדג בכפות הרגליים

בדיקת בטיחות

וודא שהסביבה בטוחה ונטולת סכנות

4

צלצול למד"א

התקשר מיד ל-101 ובקש דפיברילטור

בדיקת נשימה

התבונן בתנועות החזה, הקשב לקולות נשימה או הרגש נשיפה

טכניקת עיסויים לתינוקות

משטח עבודה

- בצע החייאה על משטח קשיח
- לא על מזרון, ספה או משטח רך
- זאת כדי להבטיח שהלחיצות יהיו אפקטיביות

מיקום ועומק

- השתמש ב-2 אצבעות במרכז החזה
- עומק לחיצה: כ-4 ס"מ (שליש עומק החזה)
- קצב: 100-120 לחיצות לדקה

הדבקת דפיברילטור על תינוק

מיקום המדבקות

מדבקה על הגב

הדבק מדבקה שנייה על גב התינוק, באזור התחתון, כך שהיא ממוקמת בין השכמות

מדבקה על החזה

הדבק מדבקה אחת על החלק התחתון של החזה של התינוק

המשך טיפול

- בצע עיסויים בעזרת 2 אצבעות במרכז החזה של התינוק
- שמור על קצב של 100 עד 120 לחיצות בדקה
- המשך לבצע עיסויים עד הנעת צוות רפואי או עד שהתינוק חזר לנשום
- השאר את הדפיברילטור מחובר לכל אורך פעולות ההחייאה

דגשים חשובים

- ביצוע החייאה על משטח קשיח בלבד
- כוח הלחיצה: שני אצבעות במרכז החזה
- חיבור דפיברילטור: השאר מחובר לאורך כל ההחייאה
- פעולה מהירה: הזמן שלוקח לפעול יכול להשפיע על סיכויי ההישרדות

מחזור הדם הגדול והקטן

כדי להבין את תפקוד לחץ הדם, חשוב להכיר את מחזור הדם של הלב, שמחלק את הדם לשני מסלולים עיקריים.

מחזור הדם הגדול

תפקיד: מעביר דם עשיר בחמצן מהלב לכל שאר חלקי הגוף

תהליך:

- הדם יוצא מהחדר השמאלי דרך האורטה
- מועבר לכל האיברים והגוף
- משחרר חמצן ומקבל פחמן דו-חמצני
- חוזר ללב דרך הוורידים

מחזור הדם הקטן

תפקיד: מעביר דם מהלב אל הריאות לשחרור פחמן דו-חמצני וקבלת חמצן

תהליך:

- הדם יוצא מהחדר הימני לעורק הריאתי
- בריאות משחרר CO_2 ומקבל O_2
- זורם דרך הוורידים הריאתיים
- חוזר לעלייה השמאלית של הלב

הקשר למדדי לחץ דם



הלחץ הסיסטולי (הערך הגבוה) נמדד כאשר הלב מתכווץ ומוציא דם מהחדר השמאלי אל האורטה (מחזור הדם הגדול). הלחץ הדיאסטולי (הערך הנמוך) נמדד כאשר הלב נמצא במנוחה וממלא את החדרים בדם (מחזור הדם הקטן).

חנק מגוף זר

רקע

חנק מגוף זר הוא מצב שבו גוף זר חוסם את קנה הנשימה. זהו מקרה שכיח, בעיקר בקרב תינוקות (הכנסת חפצים לפה) ומבוגרים (השתנקות מפיסות אוכל). במקרים חמורים, החנק יכול להוביל למצב מסכן חיים.

איך נזהה מצב של חנק?

סיפור מקרה

ילד בחדר שבו יש חפצים קטנים או סצנה דומה

תנועה אופיינית

אדם אוחז בגרונו (סימן אוניברסלי לחנק)

צבע עור

מאפיר או מכחיל

השתנקות

נפגע משתנק ולא מצליח לנשום בצורה יעילה

סוגי חסימות בחנק

חסימה חמורה

נתיב האוויר חסום לחלוטין

סימנים:

- לא יכול להשתעל - השיעול מגיע מהריאות, ובחסימה מוחלטת לא ניתן להשתעל
- לא יכול להוציא קול או לבכות - חסימת מיתרי הקול לא מאפשרת השמעת קול
- אוחז בגרון
- פנים מכחילות

דורש טיפול מיידי! 🚑

חסימה חלקית

נתיב האוויר חסום באופן חלקי

סימנים:

- יכול להשתעל בצורה חזקה
- יכול לדבר או לבכות
- מסוגל להוציא קולות
- נושם, אך בקושי

עודד השתעלות 📄

עיקרון חשוב

אם האדם יכול להשתעל, לדבר או לבכות - זו חסימה חלקית. אם הוא לא יכול לעשות אף אחד מאלה - זו חסימה חמורה הדורשת פעולה מיידית.

טיפול בחסימה חמורה - תמרון היימליך

סדר פעולות

01

הזעקת עזרה

התקשר מיידית למוקד מד"א (101)

02

מיקום המטפל

עמוד מאחורי הנפגע, כשגובה המטפל מתאים לגובה הנפגע.
במידת הצורך, פתח את רגליך ליציבות

03

תנוחת הידיים

קפל את האצבעות לאגרוף כשהאגודל מופנה כלפי חוץ

04

ביצוע לחיצות

בצע לחיצות חזקות ומהירות כלפי פנים ומעלה ברום הבטן
העליונה, מתחת לצלעות

חשוב לזכור



המשך בלחיצות עד שהגוף הזר יוצא, הנפגע מתחיל לנשום, או עד שהנפגע מאבד הכרה. **אם הנפגע מאבד הכרה - התחל בהחייאה מיידית.** לסכימת החייאה עיין בעמוד 10

מקרים מיוחדים בחנק



נפגע בכיסא גלגלים

יש לקבע את הכיסא (נעל את הבלמים), לבוא מאחור ולבצע לחיצות ברום הבטן כרגיל.



נשים בהריון

יש לבצע לחיצות על בית החזה במקום הבטן העליונה. מקם את האגרוף במרכז החזה ובצע לחיצות חזקות כלפי פנים.



חסימה חמורה ללא הכרה

יש להתחיל בהחייאה מיידית. העיסויים עוזרים לדחוף את הגוף הזר החוצה. עיין בעמוד 10



אדם כבד משקל מאוד

ניתן לבצע דחיקות כנגד קיר. הנפגע נשען על הקיר והמטפל מבצע לחיצות מלפנים.

מה אסור לעשות

- אין למצוץ את הגוף הזר
- אין להכניס אצבעות לפה אלא אם רואים את הגוף הזר בבירור
- אין לתת מים לשתייה בחסימה חמורה

טיפול בחסימה חלקית

בחסימה חלקית, הנפגע עדיין יכול לנשום, להשתעל ולהוציא קולות. המטרה היא לעזור לו להוציא את הגוף הזר בעצמו.

1 הושב את הנפגע

הושב את הנפגע במצב נוח וזקוף

2 עודד השתעלות

עודד את הנפגע להשתעל בכוח. השיעול הוא הדרך הטבעית והיעילה ביותר להוציא גוף זר

3 הרגע את הנפגע

דבר ברוגע והרגע את הנפגע. מתח וחרדה מחמירים את המצב

4 הצע שתיית מים

ניתן להציע שתיית מים בלגימות קטנות, אך רק אם הנפגע יכול לבלוע

5 עקוב אחר המצב

אם המצב מחמיר והופך לחסימה חמורה - פעל מיידית לפי הנחיות חסימה חמורה

מתי להזעיק עזרה?

הזעק עזרה רפואית אם: החסימה לא משתחררת תוך מספר דקות, המצב מחמיר, הנפגע מתקשה יותר ויותר לנשום, או אם הנפגע מאבד הכרה.

מדדים חיוניים

מדדים חיוניים הם מדידות בסיסיות של תפקודי הגוף החיוניים. הם עוזרים להעריך את מצב הנפגע ולזהות בעיות רפואיות.

נשימה (Respiration)



מספר נשימות לדקה. מעיד על תפקוד מערכת הנשימה.

תקין במבוגר: 12-20 לדקה

תקין בתינוק: 30-60 לדקה

דופק (Pulse)



מספר פעימות הלב לדקה. מעיד על תפקוד הלב וזרימת הדם.

תקין במבוגר: 60-100 לדקה

תקין בתינוק: 100-160 לדקה

טמפרטורת גוף



חום הגוף. מעיד על זיהומים או מצבי סביבה קיצוניים.

תקין: 36.5-37.5 מעלות צלזיוס

לחץ דם (Blood Pressure)



הלחץ בכלי הדם. מורכב משני ערכים: סיסטולי ודיאסטולי.

תקין: 70-90 / 110-140 מ"מ כספית

חשיבות המדידה



מדידת מדדים חיוניים עוזרת לזהות שינויים במצב הנפגע ולקבוע את דחיפות הטיפול הרפואי. תעד את המדידות והעבר אותן לצוות הרפואי.

דופק - מדידה והערכה

הדופק הוא פעימות הלב, והוא משקף את קצב פעימות הלב ואת תפקוד מערכת הדם. כאשר הלב פועם, הוא דוחף דם לכל חלקי הגוף, וההדף הזה נמדד דרך העורקים כ"דופק".

מקומות לבדיקת דופק

אדם מחוסר הכרה הדופק נמדד על העורק הקרוטידי (בצוואר)	תינוק הדופק נמדד בעורק הבריאי (ביד הפנימית)	אדם בהכרה מלאה הדופק נמדד על העורק הרדיאלי (בפרק כף היד)
--	---	--

מה בודקים כאשר מודדים דופק?

קצב הדופק	נימות הדופק	סדירות הדופק
מספר פעימות הלב לדקה	עד כמה הדופק חזק ומורגש	האם פעימות הדופק סדירות או לא
מבוגר: 60-100 לדקה	דופק חזק ונימוג מעיד על תפקוד תקין של הלב וכלי הדם	- דופק סדיר: מדוד 15 שניות והכפל ב-4 - דופק לא סדיר: מדוד דקה שלמה
תינוק: 100-160 לדקה		

לחץ דם - הבנה ומדידה

לחץ דם הוא הלחץ המופעל על דפנות העורקים והוורידים במהלך זרימת הדם בגוף. מדובר בממד חיוני לבריאות, שכן הוא יכול להוות אינדיקציה למצב הבריאותי הכללי.

לחץ דם סיסטולי

זהו הלחץ המופעל בעורקים כאשר הלב מתכווץ ומוציא דם אל הגוף.

טווח תקין: 110-140 מ"מ כספית

לחץ זה חשוב כדי שהדם, שנושא חמצן, יוכל להגיע לכל האיברים בגוף, כולל למוח.

לחץ סיסטולי נמוך מדי עלול למנוע הגעת דם עם חמצן לכל חלקי הגוף, דבר שיכול להשפיע על רמת ההכרה ואף לגרום להתעלפות.

לחץ דם דיאסטולי

זהו הלחץ המופעל בוורידים כאשר הלב במצב רפוי, כלומר כאשר הלב לא פועם אלא נח.

טווח תקין: 70-90 מ"מ כספית

לחץ זה חשוב לחזרת הדם אל הלב לאחר שהוא מוזרם לגוף.

לחץ דיאסטולי נמוך עשוי לגרום לקושי במילוי הלב בדם, דבר שעלול לפגוע ביכולת הלב לפעול בצורה תקינה.

טווח לחץ דם תקין

חשוב לזכור שהלחץ הדם הכולל צריך להיות תקין על מנת להבטיח זרימה אופטימלית של דם. טווח תקין כולל גם את הסיסטולי וגם את הדיאסטולי, עם הבדל של 30-60 מ"מ כספית בין הערכים.

עילפון

הגדרה

עילפון הוא שינוי זמני במצב ההכרה כתוצאה מירידה בהספקת החמצן למוח. זהו מצב זמני שנמשך בדרך כלל מספר שניות בלבד.

גורמים לעילפון

התייבשות חוסר נוזלים בגוף	חוסר סוכר היפוגליקמיה - רמת סוכר נמוכה בדם	התרגשות מתח רגשי או פחד פתאומי
הרחבת כלי דם שוק ונאלי (Vasovagal)	תגובות נפשיות תגובות פסיכוסומטיות	

טיפול בעילפון

1 הרמת רגלי הנפגע הרם את רגלי הנפגע כ-30 ס"מ מעל רמת הלב כדי לשפר את זרימת הדם למוח	2 שמירה על נתיב אוויר וודא שנתיב האוויר פתוח והנפגע נושם	3 במידת הצורך הזמן אמבולנס אם הנפגע לא מתעורר תוך דקה או שהמצב חוזר - הזעק עזרה רפואית
---	---	--

דגשים חשובים

- אין לסטור לנפגע
- אין לשפוך עליו מים
- לאחר התאוששות, יש לקום **בהדרגה ובאיטיות** כדי למנוע עילפון חוזר
- עילפון נמשך לרוב מספר שניות בלבד

אלרגיה ושוק אנפילקטי

הגדרה של אלרגיה

אלרגיה היא תגובה חיסונית מוגזמת לחומרים שבדרך כלל אינם מזיקים (אלרגנים). מערכת החיסון מזהה את החומר כמאיים ומשחררת כימיקלים כמו היסטמין, שגורמים לתסמינים כמו פריחה, גירוד, נפיחות, או קוצר נשימה.

שוק אנפילקטי

שוק אנפילקטי הוא תגובה אלרגית חריפה ומסכנת חיים. מתרחש כאשר הגוף מגיב בצורה קיצונית לאלרגן, מה שמוביל להידרדרות מהירה במצב הבריאותי.

גורמים נפוצים

- מזונות:** בוטנים, אגוזים, חלב, ביצים, דגים, פירות ים
- תרופות:** אנטיביוטיקה (פניצילין), תרופות אנטי דלקתיות
- עקיצות חרקים:** דבורים, צרעות
- אלרגנים סביבתיים:** אבקנים, פרוות בעלי חיים

מאפיינים עיקריים

- ירידה חדה בלחץ הדם
- נפיחות בגרון
- קשיי נשימה חמורים
- פריחה מפושטת
- תחושת חולשה
- סחרחורת

זיהוי וטיפול בשוק אנפילקטי

סימנים לשוק אנפילקטי

חשוב: כדי לזהות שוק אנפילקטי, חייבת להיות מעורבות של לפחות שני מערכות בגוף, כאשר אחת מהן קשורה למערכת הנשימה.



מערכת לב וכלי דם

דופק מהיר, ירידה בלחץ דם, חיוורון, סחרחורות, התעלפות



מערכת נשימה

קוצר נשימה, קשיי נשימה, צפצופים, נפיחות בלשון/פנים/גרונ, תחושת חנק



מערכת עיכול

בחילות, הקאות, כאבי בטן, שלשולים



עור

פריחה ממושטת, גירוד עז, אודם, נפיחות

טיפול בשוק אנפילקטי

2

חמצן

מתן חמצן להקל על קשיי הנשימה

הזרקת אפינפרין

הזרקה מיידית של אפינפרין (אדרנלין) לעצירת התגובה האלרגית

4

פינוי מידי

פינוי לבית חולים להמשך טיפול

עירוי נוזלים

עירוי נוזלים לשיפור לחץ הדם

דגשים חשובים

- מניעה:** הימנעות מחשיפה לאלרגנים ידועים
- מזרק אפינפרין:** אנשים הסובלים מאלרגיות חמורות צריכים לשאת מזרק אפינפרין לשימוש מידי
- חינוך:** הדרכת הסובבים כיצד לזהות התקף אלרגי חמור וכיצד להשתמש במזרק

הרעלות

הגדרה

הרעלה היא מצב חירום רפואי הנגרם כאשר חומרים רעילים נכנסים לגוף, פוגעים בתפקודו ועלולים לגרום לנזק חמור למערכות שונות, ואף למוות, בהתאם לסוג הרעל, הכמות וצורת החשיפה.

סימנים

- ערפול הכרה, שעשוי להתפתח עד לאובדן הכרה
- הסימנים משתנים לפי סוג הרעל
- יכולים לכלול: כאבים, קושי בנשימה, הפרעות בקצב הלב, בחילות והקאות

טיפול בהרעלה

02	01
מתן חמצן	שמירה על נתיב אוויר
במידת האפשר, ספק חמצן לנפגע	וודא שנתיב האוויר פתוח והנפגע נושם. לבדיקת הכרה עיין בעמוד 9
04	03
פינוי מהיר	זיהוי הרעל
פנה את הנפגע מיידית לקבלת טיפול רפואי. התקשר למד"א (101)	נסה לזהות את הרעל שהנפגע נחשף אליו. אם אפשרי, הבא את אריזת החומר לבית החולים

דגשים קריטיים - מה אסור לעשות

- אין לגרום להקאה - זה עלול להחמיר את המצב
- אין למתן תרופות ביתיות או "תרופות סבתא" - עלולות לגרום לתופעות לוואי מסוכנות
- אין לנסות לבצע סתירה כימית של הרעל (כמו מתן חומר בסיסי לאחר חשיפה לחומצה)

אוטם בשריר הלב (התקף לב)

הגדרה

אוטם בשריר הלב הוא מצב חירום רפואי הנגרם כתוצאה מחסימה באחד מעורקי הלב (העורקים הכליליים), מה שמוביל להפסקת אספקת הדם והחמצן לשריר הלב. חסימה זו גורמת לנזק לרקמת הלב, ואם לא יינתן טיפול מהיר, עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך או למוות.

גורמים

- טרשת עורקים (הצטברות פלאק שומני)
- קריש דם החוסם עורק כלילי
- יתר לחץ דם ממושך
- עישון
- השמנת יתר
- חוסר פעילות גופנית
- סוכרת
- מתח נפשי ממושך

סימנים

קוצר נשימה קושי בנשימה, תחושת חנק	כאבים בחזה לחץ או כאב חזק, המקרינים לזרוע שמאל, צוואר, גב או ללסת
בחילות בחילות או הקאות	הזעה מרובה הזעה קרה ומרובה
סחרחורת סחרחורת או התעלפות	חולשה חולשה כללית ועייפות

טיפול

1 הזעקת עזרה התקשר מיידית למוקד 101	2 הושב במנוחה הושב את הנפגע במנוחה ומנע מאמץ
3 החייאה במידת הצורך אם יש דום נשימה או דום לב - התחל בהחייאה (CPR). עיין בעמוד 10	4 פינוי מהיר פינוי לבית חולים לטיפול מתקדם, כולל אפשרות לביצוע צנתור

דגשים

אין להתעלם מסימנים ראשוניים - פנה מיידית לטיפול רפואי. במקרים של כאב מתמשך בחזה או חשד לאוטם, יש לפעול במהירות. הימנע ממאמץ גופני עד הגעת צוות רפואי. הטיפול המהיר יכול למנוע נזק משמעותי לשריר הלב ולהציל חיים.

סוכרת (Diabetes)

סוכרת היא מחלה כרונית שבה הגוף לא מצליח לווסת את רמות הסוכר (גלוקוז) בדם בצורה תקינה. גלוקוז מהווה מקור אנרגיה עיקרי לתאים, אך כדי להיכנס לתוך התאים, הוא זקוק להורמון בשם אינסולין, המיוצר בבלב.

סוגי סוכרת

סוכרת סוג 1

הגדרה: מחלה אוטואימונית שבה מערכת החיסון תוקפת את תאי ביתא בבלב. הגוף לא מייצר אינסולין כלל.

מאפיינים:

- מופיעה לרוב בגיל צעיר
- המטופלים תלויים בהזרקת אינסולין חיצוני לאורך כל חייהם

סוכרת סוג 2

הגדרה: מצב שבו הגוף מייצר אינסולין אך התאים מפתחים עמידות לאינסולין ואינם מגיבים אליו כראוי.

מאפיינים:

- מופיעה לרוב בגיל מבוגר
- קשורה בעיקר לאורח חיים לא בריא

השפעה על הגוף

רמות סוכר גבוהות בדם לאורך זמן עלולות לגרום לנזקים מצטברים לכלי הדם, לעצבים, לכליות ולעיניים. ללא אינסולין, הסוכר מצטבר בדם ולא נכנס לתאים, דבר שעלול להוביל לעלייה מסוכנת ברמות הסוכר ולסיבוכים חמורים.

היפוגליקמיה - רמת סוכר נמוכה

הגדרה: מצב שבו רמת הסוכר בדם יורדת מתחת ל-60 מ"ג/ד"ל.

למה זה מסוכן?

הגלוקוז הוא מקור האנרגיה העיקרי של המוח. כאשר רמות הסוכר נמוכות מדי, המוח לא מקבל מספיק אנרגיה, מה שעלול להוביל לפגיעה בתפקוד המוח, בלבול, עילפון ובמקרים קיצוניים גם לנזק מוחי ולמוות.

סימנים להיפוגליקמיה

- הזעה מרובה
- רעידות
- רעב עז
- חולשה ועייפות
- בלבול או חוסר ריכוז
- דופק מהיר
- חיוורון
- התנהגות חריגה
- במצבים קיצוניים - אובדן הכרה

גורמים להיפוגליקמיה

- מינון יתר של אינסולין או תרופות להורדת סוכר
- דילוג על ארוחות או אי אכילה מספקת
- מאמץ גופני מוגבר ללא התאמת מינון
- שתיית אלכוהול על בטן ריקה

טיפול בהיפוגליקמיה

באדם בהכרה מלאה

03	02	01
חזרה על הטיפול	המתנה	מתן מקור סוכר מהיר
במידה ואין שיפור - תן עוד מנת סוכר מהיר ופנה להמשך טיפול רפואי	המתן 10-15 דקות ובדוק שיפור בתסמינים	תן 2-3 כפיות סוכר/דבש, כוס שתייה מתוקה (מיץ פירות, קולה רגילה), או ג'ל גלוקוז במידה ויש

באדם מחוסר הכרה ונושם

השכבת המטופל על הצד	☐	אין לתת אוכל או שתייה לפה	☐
הנח את המטופל בתנוחה בטוחה (על הצד)		מחשש לחנק! זהו סיכון מסכן חיים	
מזרק גלוקגון	☐	הזעקת עזרה רפואית	☐
אם יש גישה למזרק גלוקגון - הזרק לפי ההנחיות. גלוקגון הוא הורמון המעלה את רמת הסוכר בדם		התקשר מיידית למד"א (101)	

דגשים חשובים

- הדרך אנשים עם סוכרת לשאת תמיד מקור סוכר מהיר (סוכריות גומי, ג'ל גלוקוז)
- בדוק רמות סוכר לפני ואחרי פעילות גופנית
- במקרה של חשד להיפוגליקמיה - טפל מיידית, גם אם אין גישה למד סוכר
- באדם מחוסר הכרה - עדיף שלא להמתין, הזעק עזרה במהירות

אסתמה

אסתמה היא מחלה כרונית של דרכי הנשימה התחתונות. במהלך התקף, דרכי הנשימה (הסמפונות) נעשות מוצרות עקב התנפחות הרירית, הפרשת ריר מרובה וכיווץ השרירים סביבן, מה שמקשה על כניסה ובעיקר על יציאה של אוויר מהריאות.

גורמים מעוררים

- חשיפה לאלרגנים (אבק, פריחה, פרוות חיות)
- פעילות גופנית מאומצת
- אוויר קר, זיהום אוויר או עישון
- מצבי לחץ וחרדה

סימנים וסימפטומים

- מצוקה נשימתית: נשימה מהירה ושטחית
- צפצופים: נשמעים בעיקר בזמן הוצאת אוויר
- שימוש בשרירי עזר: בולטות של שרירי הצוואר והצלעות
- שיעול וקוצר נשימה
- קושי להשלים משפטים (מדבר במילים בודדות)
- תנוחת "טריפוד": רכון קדימה עם ידיים על הברכיים



טיפול באסתמה

02	01
הרגעה	הושבת המטופל
מתח וחרדה מחמירים את כיווץ הסמפונות. דבר ברוגע והרגע את המטופל	הושבה זקופה או רכינה קדימה (תנחות נוחות) היא הדרך היעילה ביותר להקל על הנשימה
04	03
הרחקה מגורם מעורר	עזרה בנטילת משאף
הוצא את המטופל מאזור עם אבק, עשן או פריחה	אם למטופל יש משאף אישי (כמו ונטולין), סייע לו להשתמש בו
06	05
פינוי	חמצן
חייג למד"א (101) במידה ואין שיפור מהיר לאחר השימוש במשאף או אם יש הדרדרות ברמת ההכרה	במידה וקיים ציוד רפואי וסמכות, תן חמצן במסכה

דגשים חשובים - סכנת חיים

- **התעייפות של המטופל** (הפסקת המאמץ הנשימתי) או **ירידה ברמת ההכרה** הם סימנים קריטיים לקריסת מערכות
- אבחנה מبدלת: חשוב לוודא שלא מדובר בחנק מגוף זר (היסטוריה של אכילה לפני האירוע)
- במקרה של אובדן הכרה והפסקת נשימה, יש להתחיל בביצוע סכימת החייאה (CPR) בשילוב דפיברילטור. עיין בעמוד 10

שבץ מוחי (CVA)

הגדרה

שבץ מוחי הוא אירוע חירום הנגרם מהפרעה פתאומית באספקת הדם למוח, מה שמוביל לפגיעה בתפקוד המוחי. קיימים שני סוגים עיקריים:

שבץ איסכמי (חסימתי)

נגרם כתוצאה מחסימת כלי דם במוח

שבץ המורגי (דימומי)

נגרם כתוצאה מקרע של כלי דם במוח ודימום לתוך הרקמה המוחית

גורמים

יתר לחץ דם

טרשת עורקים

קרישי דם

הפרעות בקצב הלב

סוכרת

עישון

כולסטרול גבוה

השמנת יתר

זיהוי וטיפול בשבץ מוחי

סימנים לשבץ מוחי



קושי בדיבור

קושי פתאומי בדיבור או בהבנה



חולשה או שיתוק

חולשה פתאומית או שיתוק בצד אחד של הגוף (ביד, ברגל או בפנים)



קושי בשיווי משקל

קושי בשיווי משקל או קואורדינציה



בעיות ראייה

שטטוש ראייה פתאומי בעין אחת או בשתיים



אובדן הכרה

במקרים חמורים - אובדן הכרה



כאב ראש חמור

כאב ראש פתאומי וחמור ללא סיבה ברורה

טיפול בשבץ מוחי

2

הושב במנוחה

הושב את הנפגע במנוחה עם ראש מוגבה

הזעקת עזרה

התקשר מיידיית למוקד 101

4

החייאה במידת הצורך

אם יש דום נשימה או דום לב - התחל ב-CPR

פינוי מהיר

פינוי לבית חולים לבדיקות וטיפול מתאים

דגשים קריטיים

- הזמן הוא גורם קריטי - טיפול מהיר בשבץ איסכמי תוך מספר שעות יכול למנוע נזק מוחי חמור
- אין למתן מזון או שתייה לנפגע עד להערכת מצב בליעתו
- אין לנסות להזיז את הנפגע, במיוחד אם הוא חסר הכרה
- שמירה על לחץ דם תקין, תזונה בריאה ואורח חיים פעיל יכולים לסייע במניעת שבץ

פרכוסים

הגדרה

פרכוסים הם אירוע פתאומי הנגרם כתוצאה מפעילות חשמלית בלתי תקינה במוח, הגורמת לתנועות לא רצוניות, איבוד הכרה או שינויים בהתנהגות ובתחושות. הפרכוסים יכולים להתרחש בעוצמות שונות, ממקומיים ועד כלליים.

גורמים לפרכוסים

חום גבוה בתינוקות

חום גוף גבוה במיוחד בתינוקות (פרכוסי חום), נפוץ בגילאי 6 חודשים עד 5 שנים

היפוגליקמיה

ירידה חדה ברמת הסוכר בדם.
לטיפול עיין בעמוד 33

אפילפסיה

הפרעה נוירולוגית המתבטאת בפרכוסים חוזרים

טיפול בעת פרכוס

03	02	01
הטה את הראש הצידה	הנח כרית מתחת לראש	הרחק חפצים מסוכנים
הטה את ראש האדם הצידה כדי לסלק הפרשות ולמנוע חסימת נתיב אוויר, במידה וזה לא מפריע לפרכוס. אין לנסות להחזיק את האדם בכוח	הנח כרית או בגד רך מתחת לראשו של האדם	הרחק רהיטים, חפצים חדים או קשים כדי למנוע פציעה
05	04	
הזעק עזרה רפואית	תנחת התאוששות	
התקשר מיד למד"א (101) בכל מקרה של פרכוס	הנח את האדם בתנוחת התאוששות (על הצד) לאחר שהפרכוס מסתיים	

דגשים חשובים - מה אסור לעשות

- אין לנסות להעיר את האדם במהלך הפרכוס
- אין לסטור לחולה או לנסות למנוע ממנו לפרכס
- אין להכניס אצבעות או חפצים לפיו
- אין לשפוך עליו מים
- רוב הפרכוסים יחלפו תוך מספר דקות

פרכוסֵי חום בתינוקות

פרכוסֵי חום בתינוקות הם תגובה לעלייה חדה בחום הגוף, ונפוצים בעיקר בגילאי 6 חודשים עד 5 שנים.

טיפול בפרכוסֵי חום

- 1

הרחק חפצים מסוכנים

שמור על סביבת התינוק בטוחה ואל תנסה לעצור את התנועות שלו
- 2

הנח כרית מתחת לראש

הנח כרית או בגד רך מתחת לראשו ושמור על נתיב אוויר פתוח
- 3

הורדת חום

לאחר הטיפול הראשוני, קח מגבת רטובה במים פושרים והנח בעדינות על המצח, החזה, וכפות הרגליים של התינוק כדי לסייע בהורדת החום
- 4

הזעק עזרה

התקשר למד"א (101) מיידית

חשוב לזכור

בצע את הורדת החום בזהירות ורק אם המצב מאפשר, מבלי להפריע למעבר האוויר. **אין להשתמש במים קרים** - רק מים פושרים. אין לתת תרופות להורדת חום במהלך הפרכוס.

התייבשות

הגדרה

התייבשות מוגדרת כהפרעה במאזן הנוזלים בגוף. ידוע כי מעל 60% מהגוף מורכב מנוזלים, וירידה בכמות הנוזלים יכולה לשקף סכנת חיים מיידית. התייבשות מתרחשת כאשר יש אובדן נוזלים גבוה מדי או חוסר במתן נוזלים.

גורמים להתייבשות

סימני התייבשות

- חוסר שתייה - חוסר בצריכת נוזלים מספיק
- מצב מזג אוויר חם - טמפרטורות גבוהות מגבירות את ההזעה
- פעילות גופנית מאומצת
- הקאות או שלשולים
- מחלות עם חום גבוה
- חיוורון
- בחילות והקאות
- סחרחורת
- חולשה
- כאבי ראש
- הכרה מתדרדרת
- צמא עז
- יובש בפה ובעור

טיפול בהתייבשות

03	02	01
הזעק עזרה בעת הצורך	החזר נוזלים בשתייה איטית	הרחקה למקום קריר ומוצל
אם המצב לא משתפר או מחמיר - התקשר למד"א (101)	החזר נוזלים בשתייה איטית דרך הפה. שתייה מהירה עלולה לגרום להקאות	העבר את האדם למקום מוצל וקריר כדי להקל עליו ולמנוע המשך אובדן נוזלים

דגשים חשובים

- התייבשות יכולה להתפתח במהירות, לכן חשוב לשים לב לסימנים הראשונים ולהגיב בהתאם
- עקוב אחרי מצב הנפגע בכל מספר דקות, כדי לוודא שאין שינוי שלילי במצבו
- במזג אוויר חם - שתה מים באופן קבוע גם אם אינך מרגיש צמא
- ילדים וקשישים נמצאים בסיכון גבוה יותר להתייבשות

מניעת התייבשות

- שתה לפחות 8-10 כוסות מים ביום
- הגבר צריכת נוזלים בימים חמים או בזמן פעילות גופנית
- הימנע משתיית אלכוהול או קפאין מרובים
- שים לב לצבע השתן - שתן בהיר מעיד על הידרציה טובה

טראומה - מבוא

רקע - ממה טראומה יכולה להיגרם?

טראומה היא פגיעה פיזית הנגרמת כתוצאה מאירוע חיצוני, והיא יכולה להיגרם ממגוון סיבות:

פציעות ספורט	נפילות מגובה	תאונות דרכים
אלימות פיזית	תאונות עבודה	פגיעות חודרות דקירות או ירי
אסונות טבע		

טראומה יכולה להשפיע על כל אחד מהאיברים בגוף, והתגובה הפיזיולוגית של הגוף לטראומה תלויה במידת החומרה ובסוג הפגיעה. במקרים רבים, טראומה יכולה להוביל לסיבוכים ארוכי טווח כמו פגיעות עצביות, בעיות תפקודיות ושינויים נפשיים.

היפותרמיה (מכת קור)

הגדרה

היפותרמיה מוגדרת כמצב בו טמפרטורת הגוף צונחת מתחת ל-35 מעלות צלזיוס. מצב זה משבש את תפקוד מערכות הגוף ועלול להוביל למוות.

סימנים וסימפטומים



דגש חשוב: היפותרמיה בנפגעי טראומה

חשוב לזכור: היפותרמיה היא לא רק תוצאה של מזג אוויר קר. **נפגע המאבד דם נמצא בסיכון גבוה מאוד להיפותרמיה, גם ביום חם!**

- איבוד דם משמעותי איבוד היכולת להוביל חום בגוף
- ירידת חום הגוף פוגעת במנגנון קרישת הדם, מה שגורם להמשך הדימום ויוצר מעגל חוזר קטלני
- חובה לחמם כל פצוע מדמם!

טיפול בהיפותרמיה

01	הרחקה מהקור	העבר את הנפגע למקום סגור, מוצל או מוגן מרוח
02	הסרת בגדים רטובים	בגדים רטובים מאיצים את איבוד החום פי 25! הסר אותם בזהירות
03	בידוד וחימום	עטוף את הנפגע בשמיכות (רצוי שמיכה טרמית) וחמם את הראש
04	מתן שתייה חמה	אך ורק אם הנפגע בהכרה מלאה. לבדיקת הכרה עיין בעמוד 9
05	פינוי דחוף	היפותרמיה היא מצב חירום רפואי הדורש השגחה צמודה. התקשר למד"א (101)

דגשים קריטיים - מה אסור לעשות

- אין לעסות או לשפשף את גפי הנפגע (עלול להזרים דם קר מדי מהפריפריה ללב ולגרום לדום לב)
- אין לחמם את הנפגע בחימום אגרסיבי מדי (כמו מים רותחים) למניעת כוויות והלם
- עקוב אחר רמת ההכרה של המטופל לפי סיווג AVPU. עיין בעמוד 9
- במקרה של אובדן הכרה והפסקת נשימה, יש להתחיל בביצוע סכימת החייאה (CPR). עיין בעמוד 10

הכשת נחש

בישראל קיימים כ-41 מיני נחשים, מתוכם 9 מינים ארסיים. הנפוץ והמסוכן שבהם באזורי המגורים הוא הצפע הארסי.

סימנים מקומיים

- סימני דקירה (לרוב שתיים)
- כאב עז
- נפיחות מקומית
- אודם או שינוי גוון העור באזור הפגיעה

סימנים חמורים

- ירידה בלחץ דם
- הפרעות בקצב הלב
- טשטוש הכרה עד אובדן הכרה מוחלט

סימנים כלליים

- חולשה
- דופק מהיר
- קוצר נשימה
- בחילות והקאות

טיפול בהכשת נחש

סכימת טיפול (עשה)

01	בטיחות (Safety)	02	מנוחה מוחלטת	03	קיבוע האיבר הפגוע
וודא שהסביבה בטוחה למטפל ולנפגע. אין לנסות לתפוס את הנחש, אך רצוי לצלם אותו מרחוק לזיהוי בבית החולים		השכב את הנפגע והרגע אותו. פעילות גופנית וסטרטס מעלים את קצב הלב ומזרזים את התפשטות הארס		קבע את הגפה המוכשת (בדומה לקיבוע שבר) למזעור תנועת שרירים המזרזת את זרימת הארס	
04	הסרת תכשיטים ובגדים לוחצים	05 חיוג למד"א			
הסר מחשש להתפתחות נפיחות שתעצור את זרימת הדם		התקשר ל-101 והזעק צוות רפואי לפינוי דחוף לבית החולים			

דגשים - מה אסור לעשות

- אין למצוץ את הארס
- אין להניח חסם עורקים
- אין לקרר את מקום ההכשה
- אין לתת לנפגע משקאות אלכוהוליים
- עקוב אחר רמת ההכרה של המטופל. לסיווג הכרה ע"ין בעמוד 9
- במקרה של אובדן הכרה והפסקת נשימה, יש להתחיל בביצוע סכימת החייה (CPR). עיין בעמוד 10

פגיעות ראש

פגיעות ראש כוללות חבלות קלות עד חמורות בגולגולת, במוח או בקרקפת. נזק מוחי חמור עלול להוביל להשלכות קשות ואף מסכנות חיים.

סימנים

סיפור מקרה תאונה, נפילה, מכה לראש	שינויים בהכרה אובדן הכרה או שינויים במצב ההכרה	בחילות והקאות
כאבי ראש חזקים	דימום או נוזל מהאף או מהאוזניים	חולשה או שיתוק באיבר אחד או יותר
בלבול חוסר יכולת לתפקד או להגיב	שינויים בראיה ראיה מטושטשת או כפולה	סימני שברים שקעים או חתכים בגולגולת

טיפול

1 שמירה על נתיב אוויר פתוח וודא שהנפגע נושם. לבדיקת נשימה עיין בעמוד 10	2 בדיקה ומעקב אחרי מצב ההכרה עקוב אחר רמת ההכרה של הנפגע. לסיווג הכרה עיין בעמוד 9	3 פינוי מהיר לבית חולים לצורך בדיקות ואבחון באמצעות הדמיה. התקשר למד"א (101)
---	--	--

דגשים

- הימנע מהזזת הנפגע ללא צורך, במיוחד במקרה של חשד לפגיעה בעמוד השדרה
- פנה לטיפול רפואי בכל חשד לפגיעת ראש, גם אם הנפגע בהכרה מלאה
- במקרה של דימום - הפעל לחץ עדין עם תחבושת נקייה

חבלה בעמוד השדרה

רקע

פגיעות בעמוד השדרה נחשבות למסוכנות ביותר, שכן הן עלולות לפגוע בתפקוד העצבי ולגרום לשיתוק חלקי או מלא, בהתאם למיקום החבלה.

סימנים

סיפור מקרה תאונה, נפילה מגובה, מכה חזקה לגב או צוואר	כאבים עזים בגב, בצוואר או לאורך עמוד השדרה
חוסר תחושה חוסר תחושה או שיתוק בגפיים	קושי בתנועות קושי בתנועות או איבוד יכולת תנועה

טיפול

1 אין להזיז אין להזיז את הנפגע עד להגעת צוות רפואי מיומן	2 שמור על יצי שמור על יציבות הצוואר והגב (במיוחד אם הנפגע בהכרה מלאה)	3 פינוי מהיר פינוי לבית חולים תוך קיבוע עמוד השדרה בעזרת צווארון וגבס מתנפח
--	---	---

דגש קריטי

טפל בזהירות ובמיוחד הימנע מהזזת הנפגע, כיוון שכל תזוזה לא נכונה עלולה להחמיר את הפגיעה העצבית ולגרום לשיתוק קבוע. במקרה של חשד לפגיעה בעמוד השדרה, יש לקבע את הראש והצוואר ולא לאפשר תנועה עד להגעת צוות מקצועי.

פגיעות חזה

רקע

פגיעות חזה יכולות לכלול פציעות חודרות או קהות באזור החזה, שעלולות לפגוע בריאות, בלב או בכלי דם גדולים.

סימנים

- סיפור מקרה: תאונה, מכה, דקירה או ירי
- קושי בנשימה או נשימה שטחית
- כאבים חזקים באזור החזה
- סימנים של חבלה חיצונית כמו חבורות או דימום
- כחול בעור או הופעת אוויר מתחת לעור
- ירידה בלחץ דם (המובילה לסחרחורת או עילפון)
- כאב מקרין לכתף, יד או גב

טיפול

01	שמירה על נתיב אוויר	02	בדיקת מצב הנשימה
וודא שנתיב האוויר פתוח והנפגע נושם		בדוק את מצב הנשימה והערך תפקוד הלב	
03	טיפול בפציעה חודרת	04	פינוי מהיר
במידה ויש פציעה חודרת - עצור דימום וכסה את הפצע בתחבושת אטומה		פינוי מהיר לבית חולים לטיפול כירורגי. התקשר למד"א (101)	

דגשים

- במקרים של פגיעת חזה חמורה יש לשמור על מנוחה מלאה ולהימנע ממאמץ
- פגיעות חזה יכולות להוביל לדום לב או לנשימה ולכן יש להיות מוכנים לפעולות החייאה. לסכימת החייאה עיין בעמוד 10
- במקרה של פצע חודר - אין להוציא את החפץ התקוע, יש לקבע אותו במקום

שברים בגפיים

רקע

שברים בגפיים הם תוצאה של חבלות ישירות או עומסים חזקים המופעלים על העצם. שבר יכול להיות סגור (העצם שבורה אך העור שלם) או פתוח (בו העצם חודרת את העור).

סימנים

כאבים חדים

כאבים חדים באזור הפגוע

סיפור מקרה

תאונה, נפילה, מכה חזקה

נפיחות ודימום

נפיחות ודימום פנימי או חיצוני

עיוות

עיוות ברור בצורת הגפה

פגיעה בעצב

סימנים של פגיעה בעצב (חוסר תחושה או שינוי במצב התחושה)

חוסר יכולת תנועה

חוסר יכולת להזיז את הגפה בצורה תקינה

טיפול בשברים בגפיים

03	02	01
פינוי מהיר	טיפול בשבר פתוח	קיבוע האזור השבור
פינוי מהיר לבית חולים לצילום ואבחון, לעיתים תוך צורך בניתוח או קיבוע בגבס	במידה והשבר פתוח - עצור את הדימום באמצעות תחבושת סטרילית. אין לנסות להחזיר את העצם למקומה	קבע את האזור השבור כדי למנוע תזוזה של העצם. השתמש בסד, קרש, או כל חומר קשיח זמין

עקרונות קיבוע

- קבע את המפרק מעל ומתחת לשבר
- השאר את הגפה במצב שבו היא נמצאת - אין לנסות ליישר
- בדוק דופק ותחושה בקצה הגפה לפני ואחרי הקיבוע
- אם יש נפיחות - הסר תכשיטים ושעונים לפני שהנפיחות מחמירה

דגשים חשובים

- **אין לנסות ליישר את השבר בעצמך** - זה עלול לגרום לנזק נוסף
- במקרה של שבר פתוח, יש להיזהר ממגע ישיר עם העצם ולכסות את הפצע עד להגעת צוות רפואי
- שברים יכולים לגרום לדימום פנימי משמעותי - עקוב אחר סימני שוק (חיוורון, דופק מהיר, סחרחורת)
- במקרה של שבר בירך או אגן - אין להזיז את הנפגע כלל

מבחן לדוגמא

בחן את עצמך

דגש 

דף התשובות נמצא בעמוד האחרון

שאלה 1: תוך כמה זמן מרגע הפסקת אספקת החמצן למוח מתחיל להיווצר נזק תאי בלתי הפיך (מוות מוחי)?

- א. תוך 30 שניות
- ב. בין 1 ל-2 דקות
- ג. מעל 6 דקות
- ד. בדיוק 10 דקות

שאלה 2: הגעת לנפגע תאונת דרכים. הוא אינו מגיב לקריאת שמך, אך כאשר אתה לוחץ לו בחוזקה על שריר הטרפז הוא נאנח ומזיז את ידו. מהי רמת ההכרה שלו לפי סיווג AVPU?

- א. V - Verbal (מגיב לקול)
- ב. P - Pain (מגיב לכאב)
- ג. A - Alert (הכרה מלאה)
- ד. U - Unconscious (חוסר הכרה)

שאלה 3: מהו תפקידו של "מחזור הדם הקטן" בגוף האדם?

- א. הזרמת דם עשיר בחמצן מהלב לכל חלקי הגוף
- ב. הזרמת דם עני בחמצן מהלב לריאות לצורך שחלוף גזים וחזרה ללב
- ג. הזרמת דם מהקיבה לכבד לצורך סינון רעלים
- ד. הזרמת דם מהמוח חזרה אל הלב בלבד

שאלה 4: מהו ההבדל העיקרי בטכניקת העיסויים בין החייאת מבוגר להחייאת ילד (גיל 1 עד 8)?

- א. אין שום הבדל, מבצעים החייאה בדיוק כמו במבוגר
- ב. בילד משתמשים ביד אחת בלבד ועומק הלחיצה הוא כ-5 ס"מ
- ג. בילד משתמשים בשתי אצבעות בלבד במרכז החזה
- ד. בילד מבצעים רק הנשמות ללא עיסויי חזה כלל

שאלה 5: במהלך החייאת תינוק (מתחת לגיל שנה), מהי טכניקת הלחיצה הנכונה?

- א. הנחת התינוק על כרית רכה כדי למנוע שבירים
- ב. שימוש בבסיס כף היד בעומק של 5-6 ס"מ
- ג. לחיצה על הבטן העליונה כדי לסייע לסרעפת
- ד. שימוש בשתי אצבעות במרכז החזה על משטח קשיח

מבחן לדוגמא

שאלות 6-10

שאלה 6: במהלך החייאה, המכשיר (דפיברילטור) מנתח את הקצב וממליץ על מתן שוק. מהי הפעולה החשובה ביותר לפני לחיצה על כפתור השוק?

- א לוודא שאף אחד, כולל המטפל, לא נוגע במטופל ולהכריז בקול "כולם לזוז"
- ב להגביר את קצב עיסויי החזה כדי להכין את הלב למכה
- ג לבדוק דופק פעם נוספת כדי לוודא שהמכשיר לא טעה
- ד להוריד לנפגע את הנעליים כדי למנוע הארקה של החשמל

שאלה 7: מהו טווח הדופק התקין במנוחה עבור תינוק?

- א 60 עד 100 פעימות לדקה
- ב 100 עד 160 פעימות לדקה
- ג 12 עד 20 פעימות לדקה
- ד מעל 200 פעימות לדקה

שאלה 8: מהו לחץ דם סיסטולי ומהו הטווח התקין שלו במבוגר?

- א הלחץ בזמן התכווצות הלב, טווח תקין: 110-140 מ"מ כספית
- ב הלחץ בזמן מנוחת הלב, טווח תקין: 70-90 מ"מ כספית
- ג ההפרש בין הדופק ללחץ הדם
- ד הלחץ הנמדד בוורידים בזמן חזרת הדם

שאלה 9: אדם במסעדה אוחז בגרונו, פניו מכחילים והוא אינו מסוגל להוציא הגה או להשתעל. מה עליך לעשות?

- א לתת לנפגע לשתות מים מיד
- ב לעודד את הנפגע להשתעל בלבד
- ג לבצע מיד תמרון היימליך (לחיצות ברום הבטן)
- ד להשכיב אותו ולהרים את רגליו

שאלה 10: תינוק בן 7 חודשים הפסיק להשמיע קול בזמן משחק, הוא אינו משתעל ופניו מכחילים. מהו סדר הפעולות לטיפול?

- א החזקת התינוק מהרגליים כשהראש כלפי מטה וטלטולו
- ב הכנסת אצבע עמוק לפה כדי לנסות לדגור את הגוף הזר
- ג ביצוע תמרון היימליך ברום הבטן בדיוק כמו במבוגר
- ד 5 טפיחות על הגב ו-5 לחיצות חזה לסירוגין עד שהגוף הזר ייצא

מבחן לדוגמא

שאלה 11: מהו הטיפול המיידני המומלץ לאדם שאיבד את הכרתו למספר שניות והתעורר (עילפון)?

- א הרמת רגלי הנפגע, שמירה על נתיב אוויר והרגעתו
- ב התזת מים קרים על הפנים ומתן סטירה קלה
- ג מתן שתייה מתוקה בעודו שוכב ללא הכרה
- ד הקמתו המיידית והליכה מהירה כדי "להתעורר"

שאלה 12: מהם התנאים הנדרשים כדי להגדיר מצב כ"שוק אנפילקטי" (מסכן חיים)?

- א מעורבות של לפחות שתי מערכות גוף (למשל נשימה ועור/דם)
- ב הופעת פריחה קלה וגירוד מקומי בלבד
- ג ירידה בטמפרטורת הגוף מתחת ל-35 מעלות
- ד כאב חד בזרוע שמאל המקרין ללסת

שאלה 13: הגעת לחולה סוכרת שנראה מבולבל, מזיע מאוד ורועד. הוא בהכרה. מה הטיפול הנכון?

- א מתן סוכר זמין (שתייה מתוקה, שוקולד, סוכר)
- ב הזרקת אינסולין מיד
- ג המתנה ללא מתן אוכל מחשש להקאה
- ד ביצוע עיסויי חזה

שאלה 14: מהו הסימן הקלאסי ביותר לאוטם בשריר הלב (התקף לב)?

- א לחץ חזק בחזה המקרין לזרוע, ללסת או לגב
- ב דופק איטי מאוד וחיוורון קיצוני
- ג חוסר יכולת להזיז את צד ימין של הגוף
- ד צפצופים חזקים בנשימה בזמן הוצאת אוויר

שאלה 15: נער סובל מהתקף אסתמה, הוא רכון קדימה ומתקשה לדבר. מה עליך לעשות?

- א להושיב אותו, להרגיעו ולסייע בנטילת משאף אישי
- ב להשכיב אותו על הגב עם רגליים מורמות
- ג לעודד אותו לבצע ריצה קלה כדי לפתוח את הריאות
- ד לתת לו לשתות כוס חלב חם

מבחן לדוגמא

שאלות 16-20

שאלה 16: מהם הסימנים לזיהוי מהיר של שבץ מוחי (CVA)?

- א חום גבוה, פריחה וכאבי בטן
- ב דופק מהיר, הזעה ורעב עז
- ג צניחת פנים (חיוך עקום), חולשה ביד אחת ודיבור מבולבל
- ד קוצר נשימה, צפצופים ולחץ בחזה

שאלה 17: מהי הפעולה הנכונה ביותר בזמן שאדם מפרנס (התקף אפילפסיה)?

- א הכנסת חפץ קשיח לפה כדי שלא ינשון את הלשון
- ב תפיסת הגפיים בכוח כדי להפסיק את הרעידות
- ג שפיכת מים קרים על פניו
- ד הרחקת חפצים מסוכנים והגנה על ראשו באמצעות משהו רך

שאלה 18: הגעת לנער שנעקץ על ידי עקרב צהוב בכף הרגל. הוא סובל מכאב עז, דופק מהיר והקאות. מה הטיפול?

- א הרגעה, קיבוע הרגל ופינוי דחוף לבית החולים
- ב הנחת חסם עורקים בירך כדי למנוע מהארס להתפשט
- ג צריבת מקום העקיצה בעזרת חום
- ד מתן הרבה מים לשתות כדי לדלל את הארס

שאלה 19: מהו הטיפול הנכון ביותר במקרה של הכשת נחש?

- א חיתוך מקום ההכשה ומציצת הארס
- ב הנחת חסם עורקים מעל מקום ההכשה
- ג קיבוע האיבר הפגוע, מנוחה מוחלטת ופינוי מהיר
- ד קירור המקום בקרח ישירות על הפצע

שאלה 20: נפגע נפל מגובה, הוא בהכרה אך מתלונן על חוסר תחושה ברגליים. מהי הפעולה הקריטית?

- א הושבת הנפגע כדי לבדוק את מצב נשימתו
- ב קיבוע ידני של הראש והצוואר ומניעת כל תזוזה של הנפגע
- ג הרמת רגליו כדי למנוע שוק
- ד עזרה לנפגע לנסות לעמוד כדי לראות אם הוא משותק

מבחן לדוגמא

שאלות 21-25

שאלה 21: נפגע ראש בתאונה נמצא מבולבל, סובל מבחילה ויוצא לו נוזל שקוף מהאוזן. מה זה מעיד וכיצד נפעל?

- א חדירת מים לאוזן; יש להטות את הראש הצידה לניקוז
- ב סימן לעילפון מתקרב; יש להרים את הרגליים בלבד
- ג חשד לשבר בבסיס הגולגולת; אין לחסום את האוזן ויש לקבע את הצוואר
- ד פגיעה קלה בלבד; יש לתת לנפגע לשטוף פנים

שאלה 22: איך מטפלים בשבר פתוח בגפה (כאשר העצם בולט)?

- א ניסיון להחזיר את העצם למקומה מתחת לעור
- ב עצירת דימום פורץ, כיסוי סטרילי של העצם וקיבוע הגפה כפי שהיא
- ג יישור הגפה בכוח כדי שיהיה קל לקבע אותה
- ד שטיפת העצם במים זורמים במשך 10 דקות

שאלה 23: הנעת לזירת תאונה, רוכב אופנוע מוטל על הכביש לאחר החלקה. הוא בהכרה, צועק ומדמם מהירך. מהו סדר הפעולות הנכון?

- א בטיחות (Safety), עצירת דימום פורץ, קיבוע צוואר ידני ובדיקת נתיב אוויר
- ב הורדת הקסדה מיד כדי לוודא שהוא נושם היטב
- ג הרמת רגליו שלו כדי למנוע שוק ומתן שתייה
- ד קיבוע הרגל השבורה לפני הכל כדי להפחית את הכאב שלו

שאלה 24: במהלך הטיפול ברוכב האופנוע, זיהית דימום מאסיבי ("שפריץ") מהירך. מהי הפעולה הראשונה?

- א חיטוי המקום עם אלכוהול וכיסוי בתחבושת קלה
- ב ניקוי הדם מסביב כדי לראות בדיוק מאיפה זה יוצא
- ג הפעלת לחץ ישיר חזק על מקום הדימום (ואם לא עוזר - חסם עורקים)
- ד המתנה לצוות מד"א כי רק להם מותר להשתמש בחסם עורקים

שאלה 25: מדוע אסור להוריד קסדה לרוכב אופנוע שעבר תאונה במידה והוא נושם?

- א כי הסרת הקסדה עלולה לגרום לתזוזה בצוואר ולנזק בלתי הפיך בעמוד השדרה
- ב כי הקסדה שומרת על חום הגוף של הנפגע ומנועת היפותרמיה
- ג כי הורדת הקסדה תמיד גורמת לאיבוד הכרה מיידי
- ד כי אי אפשר לחבוש את הראש כשהקסדה מוסרת

תשובות נכונות למבחן

מפתח תשובות - קורס 44

שאלה 11: ב

שאלה 12: א

שאלה 13: ב

שאלה 14: ג

שאלה 15: ב

שאלה 6: א

שאלה 7: ב

שאלה 8: א

שאלה 9: ג

שאלה 10: ד

שאלה 1: ג

שאלה 2: ב

שאלה 3: ב

שאלה 4: ב

שאלה 5: ד

שאלה 21: ג

שאלה 22: ב

שאלה 23: א

שאלה 24: ג

שאלה 25: א

שאלה 16: ג

שאלה 17: ד

שאלה 18: א

שאלה 19: ג

שאלה 20: ב

בהצלחה במבחן! זכור - עזרה ראשונה מצילה חיים